

Assistência ao Parto - Avançada

DISTÓCIAS DE OMBRO

Imagine a seguinte situação: você está em uma maternidade e recebe uma gestante de 39 semanas, múltipara, sem intercorrências durante o pré-natal. Ela entra em trabalho de parto ativo que evolui rapidamente, o período expulsivo se inicia sem sinais de complicação e, após a saída da cabeça fetal, você percebe que ela não realiza a rotação externa habitual. O bebê fica naquilo que chamamos de **sinal da tartaruga**. Apesar da tração suave, o restante do corpo não progride. E agora? O que fazer diante dessa urgência obstétrica?

Pois bem, o que acabamos de descrever é a **distócia de ombro**, também chamada de **distócia biacromial**. Trata-se de uma emergência obstétrica com elevada morbidade e mortalidade perinatal, ou seja, realmente pode levar o feto à morte se não manejada corretamente. Por isso, é fundamental saber reconhecê-la e conhecer as manobras de resolução.

Quais são os fatores de risco para distócia de ombro?

Primeiramente, gestantes com **diabetes mellitus gestacional (DMG)** têm maior propensão a essa complicação. E aqui vale um ponto importante que costuma confundir: não é apenas pelo ganho de peso excessivo do bebê. Na verdade, geneticamente, os filhos de mães com DMG apresentam um **diâmetro biacromial** (ombro a ombro) naturalmente maior do que bebês de mães sem diabetes gestacional. É uma questão morfológica, **independente do peso**.

Outros fatores de risco incluem: **fetos macrossômicos** (acima de 4.500g), **pós-datismo** (gestações prolongadas que resultam em fetos maiores) e **obesidade materna**. No caso da obesidade, temos duas razões: primeiro, essas pacientes frequentemente cursam com hiperinsulinismo, favorecendo a macrossomia fetal;

segundo, a abundância de partes moles dificulta mecanicamente a passagem do bebê pelo canal de parto.

Como diagnosticar a distócia de ombro?

Essa é uma pergunta que gera discussão entre especialistas, pois a avaliação tem um componente subjetivo. Porém, segundo a última atualização da **Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)**, o diagnóstico é firmado quando não há desprendimento do **ombro anterior** em até **60 segundos** após o desprendimento do polo cefálico. Ou seja, a cabeça sai, mas o ombro que está voltado para a sínfise púbica não se desprende dentro desse intervalo de tempo. Guarde esse número: **60 segundos** é o marco temporal que define a distócia de ombro.

Mnemônico ALERTA – O que fazer na distócia de ombro?

Para sistematizar o manejo, utilizamos o mnemônico **ALERTA**, que organiza a sequência de condutas:

A – Ajuda: Como em qualquer urgência médica, o primeiro passo é chamar ajuda. Acione a equipe de enfermagem, o colega plantonista, monte sua equipe. Distócia de ombro não se resolve sozinho.

L – Levantar as pernas: Corresponde à **manobra de McRoberts**. Consiste em realizar a **hiperflexão e abdução das coxas** da paciente sobre o abdômen materno. Isso aumenta o espaço do estreito inferior da pelve, favorecendo a liberação do ombro anterior. Essa manobra, isoladamente, resolve a grande maioria das distócias de ombro – por isso é considerada a intervenção de primeira linha e a mais eficaz de modo isolado. Pegadinha clássica de prova: a banca descreve "hiperflexão e abdução das coxas em direção ao abdômen materno" e pergunta qual é a manobra. É McRoberts.

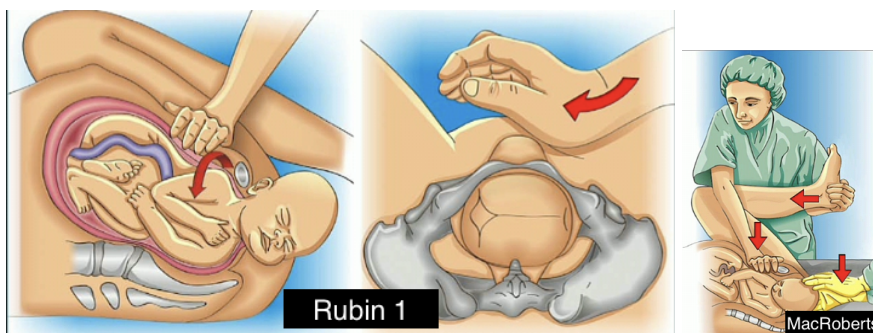
E – Pressão suprapúbica Externa: Trata-se da **manobra de Rubin 1**. Aplica-se uma pressão médio-lateral na região suprapúbica, fazendo com que o ombro anterior do

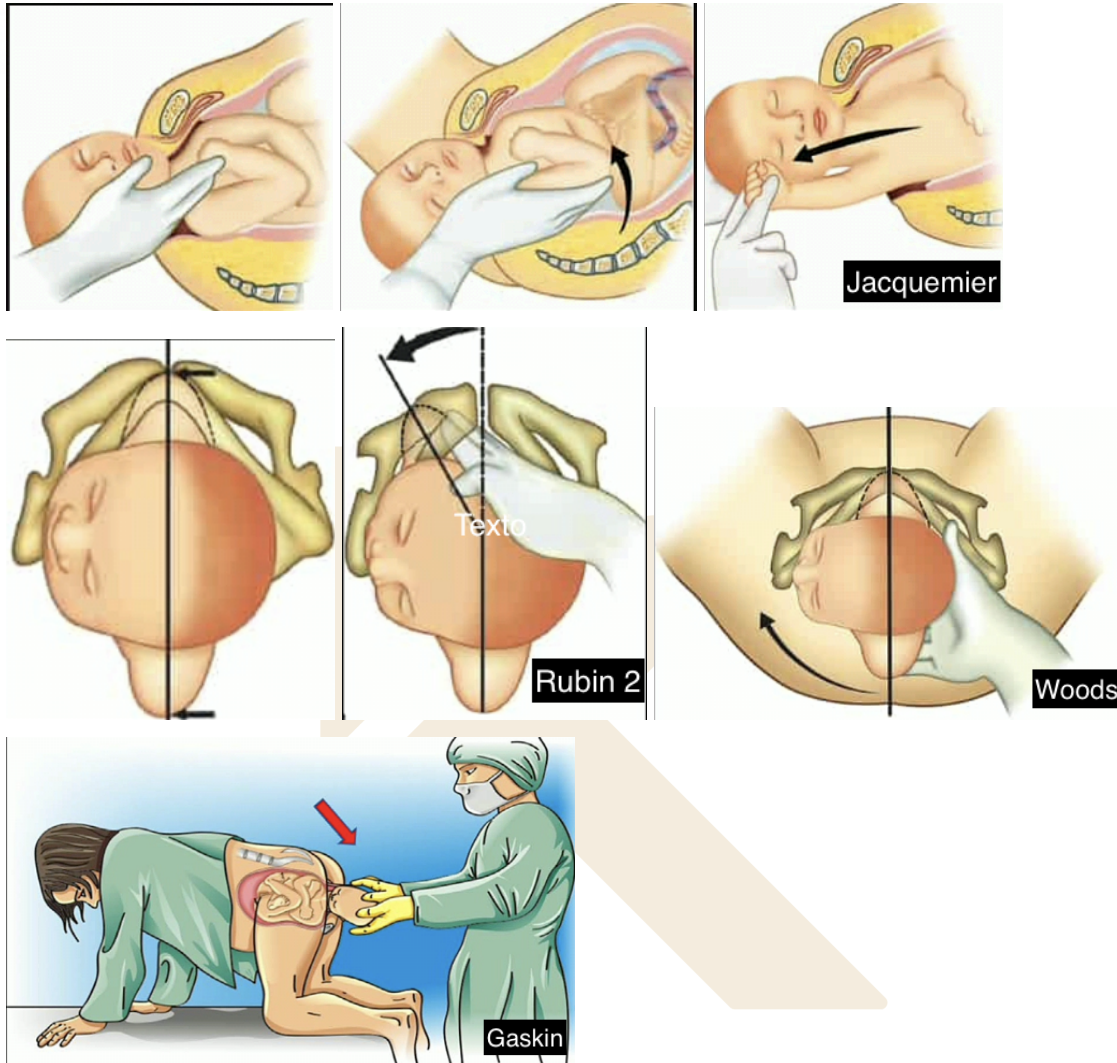
bebê gire dentro da pelve materna, facilitando seu desprendimento. Na prática, realizamos McRoberts e Rubin 1 simultaneamente: enquanto duas pessoas hiperfletam as coxas, uma terceira faz a pressão suprapúbica. Essa combinação resolve a imensa maioria dos casos.

R – Remover o braço posterior: Corresponde à **manobra de Jacquemier**. Quando as manobras externas não resolvem, partimos para manobras internas. Nessa técnica, o profissional realiza um toque vaginal, localiza o ombro posterior e o retira antes do anterior. Ao fazer isso, diminuimos o volume fetal que está ocupando o canal vaginal, criando espaço para a saída do ombro anterior.

T – Toque com manobras internas: Aqui entram duas manobras importantes. A **manobra de Rubin 2** consiste em realizar um toque vaginal, localizar o ombro anterior e empurrá-lo em direção ao tórax fetal, promovendo uma rotação interna. É essencialmente a mesma pressão da Rubin 1, porém realizada por dentro. Já a **manobra de Woods** envolve pressão na face anterior do ombro posterior do feto, promovendo rotação de todo o corpo fetal e liberando o ombro anterior da sínfise púbica.

A – Alterar a posição: Corresponde à **manobra de Gaskin**. Colocamos a paciente em **posição de quatro apoios** (gêmino-peitoral), o que aumenta o diâmetro anteroposterior da pelve. Um ponto crucial que as bancas adoram cobrar: uma vez que a paciente esteja em Gaskin, podemos repetir todas as manobras anteriores – McRoberts adaptado, Rubin 1, Rubin 2, Jacquemier, Woods. Cada manobra deve ser tentada por aproximadamente 60 segundos antes de progredir para a próxima.



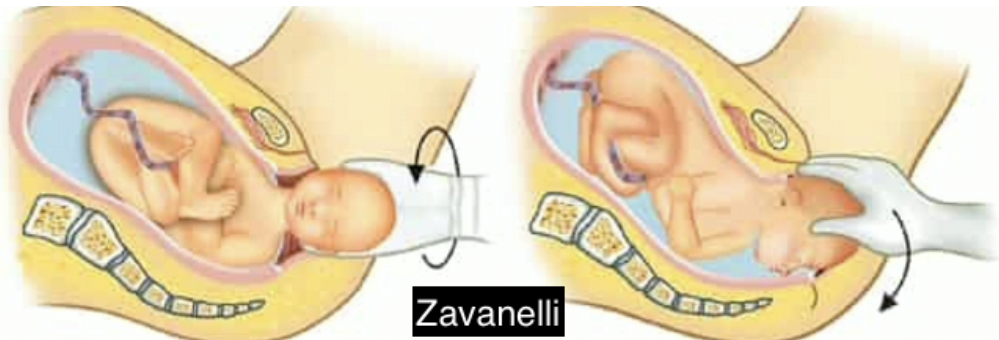


Manobras de exceção – últimos recursos

Se todas as manobras falharem, existem condutas de exceção que podem ser tentadas. São manobras dramáticas, com alta morbimortalidade materna e fetal, reservadas para situações de extrema urgência:

A **fratura intencional da clavícula** diminui o diâmetro biacromial e pode permitir a passagem do bebê. A **sinfisiotomia** consiste em seccionar a articulação da sínfise

púbica, ampliando a passagem pélvica. Por fim, a **manobra de Zavanelli** envolve rotacionar o bebê e empurrá-lo de volta para dentro do útero para realizar uma cesárea de emergência. São condutas extremas, não proscritas, mas indicadas apenas quando absolutamente nada mais funciona.



Cesárea a pedido – o que diz a legislação?

A cesárea a pedido é regulamentada pela **Resolução CFM 2284/2020**. Segundo essa norma, o médico somente pode realizar cesárea a pedido da gestante em gestações de risco habitual **a partir de 39 semanas completas**. Se uma paciente com 38 semanas solicitar cesárea eletiva sem indicação obstétrica, você não está autorizado a realizá-la.

Além disso, o médico pode se recusar a realizar uma cesárea a pedido, desde que a instituição garanta outro profissional disponível para fazê-la. É um direito de autonomia do obstetra. Por outro lado, também é direito da gestante optar pela cesariana em situações eletivas, garantido pela sua autonomia, desde que tenha sido adequadamente esclarecida sobre os riscos e benefícios de ambas as vias de parto.

E quais são esses riscos? A cesárea apresenta complicações potenciais que precisam ser claramente explicadas: **lesão vesical** (podendo necessitar de sondagem), **lesão de alça intestinal** (com risco de colostomia), **maior risco de hemorragia pós-parto** comparado ao parto vaginal, riscos inerentes à

raquianestesia, maior tempo de recuperação pós-operatória e aumento do risco de **tromboembolismo venoso**.

Muitas pacientes preferem cesárea por medo da dor do parto vaginal. Nesse caso, é fundamental esclarecer que existe o direito à **analgesia epidural de parto**, que pode ser realizada a qualquer momento da internação. Outras pacientes acreditam que o parto vaginal traz mais riscos para o bebê, quando na verdade é o contrário: o trabalho de parto prepara o bebê para o ambiente externo. Recém-nascidos de parto vaginal apresentam menor incidência de **hipoglicemia** e **disfunções respiratórias** comparados aos nascidos por cesariana.

Vivemos uma verdadeira epidemia de cesáreas – a cesárea está caminhando para se tornar a cirurgia mais realizada no mundo. Por isso, é responsabilidade do obstetra orientar de forma clara e acessível sobre os benefícios do parto vaginal, sempre que este for viável e seguro.

RESUMO DOS GATILHO

- A **distócia de ombros** é uma urgência obstétrica com alta morbimortalidade perinatal.
- O **diagnóstico** ocorre quando o ombro anterior não se desprende até **60 segundos após a saída da cabeça**.
- Os **principais fatores de risco** incluem DMG, macrosomia fetal, obesidade materna e pós-datismo.
- A **manobra de McRoberts** é a primeira e mais eficaz intervenção isolada.
- McRoberts consiste na **hiperflexão e abdução das coxas contra o abdome materno**.
- A **pressão suprapúbica externa** corresponde à **manobra de Rubin I**.
- A retirada do **braço posterior** é chamada de **manobra de Jacquemier**.
- **Rubin II e Woods** são manobras internas para **rotação dos ombros fetais**.
- A **manobra de Gaskin** coloca a gestante em **quatro apoios**, aumentando o diâmetro anteroposterior.
- A **cesariana a pedido** é permitida a partir de **39 semanas**, conforme resolução do CFM.